

口腔所見と病態

2026年3月11日2限
蒲郡市民病院歯科口腔外科
竹本 隆

口腔外科疾患

- 外 傷: 軟組織外傷、歯牙外傷、骨折
- 腫 瘍: 良性腫瘍、悪性腫瘍
- 炎 症: 骨膜炎、骨髓炎、口腔粘膜の炎症、リンパ節炎
- 囊 胞: 顎骨嚢胞、軟組織嚢胞
- 先 天 異 常: 口唇裂、口蓋裂
- 顎 変 形 症: 下顎前突症、小顎症
- 唾液腺疾患: 唾液腺の炎症、腫瘍、唾石症
- 血 液 疾 患: 口腔内出血をきたす疾患
- 神経性疾患: 三叉神経痛、顔面神経麻痺
- 顎関節疾患: 顎関節症、顎関節脱臼、顎関節強直症

腫 瘍

口腔・顎顔面に発症する
良性腫瘍、悪性腫瘍

良性腫瘍

歯源性腫瘍

歯を形成する組織に由来する腫瘍で、その大多数は顎骨内に発生するが、ときに顎骨外の歯肉部に発生することもある。
大部分は良性で、悪性はきわめて少ない。

良性歯源性腫瘍の分類

1. 良性上皮性歯源性腫瘍
(エナメル上皮腫など)
2. 良性上皮間葉混合性歯源性腫瘍
(歯牙腫など)
3. 良性間葉性歯源性腫瘍
(歯源性線維腫、歯源性粘液腫など)

WHO分類 (5th, 2024年改訂)

エナメル上皮腫

- ・歯原性上皮の増殖からなり、歯原性腫瘍の中で最も頻度が高い。
- ・発育は緩慢で、顎骨の吸収が進行すると、羊皮紙様感や波動が触知される。
- ・性差はなく、20～30歳代の下顎に多くみられる。
- ・下顎では、大臼歯部～下顎枝に70%、小臼歯部に20%、前歯部に10%がみられる。

エナメル上皮腫

患者: 11歳、男児。

初診: 20XX年12月。

主訴: 左側頬部の腫脹。

既往歴: 特記事項なし。

家族歴: 特記事項なし。

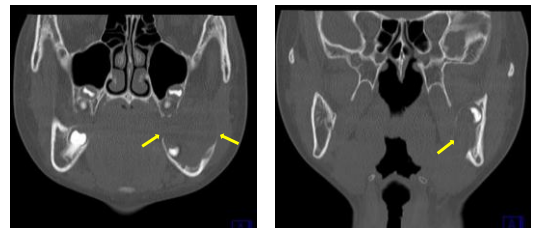
現病歴: 歯科治療中にX線にて、左側下顎骨内のX線透過像指摘され紹介来科。

現症: 左側下顎臼歯部の歯肉腫脹を認めた。

初診時パノラマX線



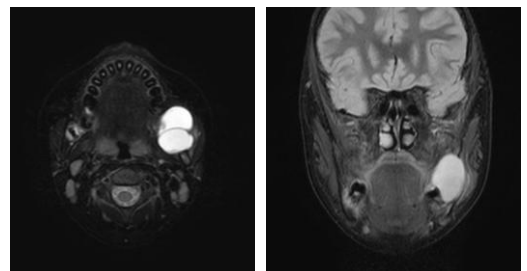
初診時CT



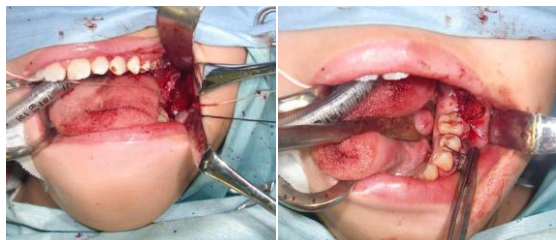
3DCT



MRI



術中所見



摘出物



歯牙腫

象牙質を主体に歯の各種硬組織および軟組織が形成されて、腫瘤状を呈した組織奇形。

歯牙腫

患者: 49歳、男性。

初診: 20XX年8月。

主訴: 右側上顎犬歯根尖部のX線不透過像の精査。

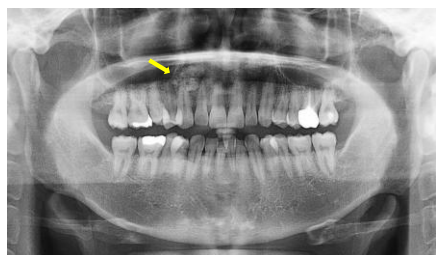
既往歴: 特記事項なし。

家族歴: 特記事項なし。

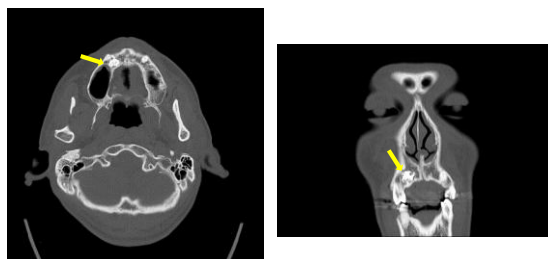
現病歴: 歯科治療中のX線にて、右側上顎犬歯根尖部にX線不透過像を認めるため紹介来科。

現症: 自覚症状なし、右側上顎犬歯に打診痛、歯肉の膨隆は認めなかった。

初診時パノラマX線



CT



術中所見



術中所見



摘出物



非歯源性良性腫瘍

1. 良性上皮性腫瘍
(乳頭腫など)
2. 良性非上皮性腫瘍
(線維腫、脂肪腫、血管腫など)

乳頭腫

- 口腔粘膜が外向性に乳頭状、疣贅状、カリフラワー状などの外観を呈して増生を示し、有茎性あるいは広基性に発育する口腔粘膜上皮の良性腫瘍。
- 発生原因は、慢性刺激、ヒトパピローマウイルス(HPV)の関与が指摘されている。
- 治療は、外科的切除。

乳頭腫



血管腫

- 頭頸部皮膚に好発する血管組織の増殖した過誤腫で、舌、口唇、頬粘膜にも好発し、まれに顎骨内にも生じる。
- Osler-Rendu-Weber症候群、Sturge-Weber症候群、Maffucci症候群の部分症として口腔に血管腫が生じる。

血管腫



脂肪腫

成熟した脂肪組織の増殖からなり、口腔では、頬部、まれに舌、口底にも生じる。きわめてまれに顎骨に生じる。

脂肪腫



多形腺腫

- 唾液腺に発生する上皮性腫瘍。
- 好発部位は、口蓋、唾液腺腫瘍で最も多く、耳下腺が多い。
- 臨床所見
発育は緩慢で、無痛性、弾性硬の境界明瞭な腫瘤。片側性。
- 治療: 腫瘍の全摘出。

多形腺腫

患者: 50歳、女性。

初診: 20XX年7月。

既往歴: 高血圧症、糖尿病、喘息。

家族歴: 特記事項なし。

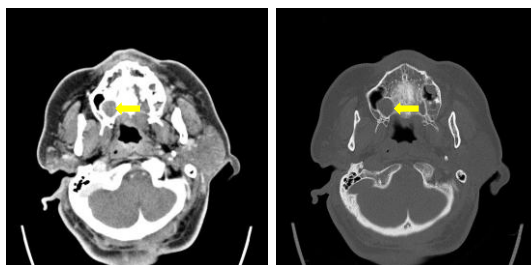
現病歴: 右側口蓋部腫脹の精査依頼にて紹介来科。

現症: 右側口蓋部に境界明瞭な18×19×15mm大の腫瘤を認めた。

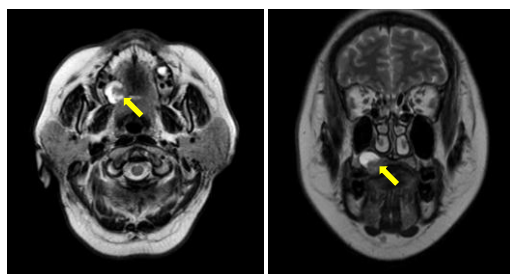
初診時口腔内所見



初診時CT



初診時MRI



術中所見



術後3か月



悪性腫瘍

口腔癌の罹患数

全がんの約1%
全頭頸部癌の約40%

男女比は3:2
年齢的には60歳代が最も多い

口腔癌の好発部位

舌 : 60.0%
頬粘膜 : 9.3%
口底 : 9.7%
上顎歯肉: 6.0%
下顎歯肉: 11.7%
硬口蓋 : 3.1%

口腔癌診療ガイドライン2019年版より引用

前癌病変

正常なものに比べて明らかに癌が発生しやすい形態的な変化を伴う組織とされ、臨床的には白板症、紅板症が挙げられ、病理組織学的には上皮性異形成がある。

口腔白板症

原因は不明である。人種や地域によって発生頻度に大きな差がある。自覚症状がなく、周囲の健康粘膜よりやや盛り上がった、境界明瞭な白色の病変であるが、角化層の厚さが均一なもの、角化層の厚さが不均一で凹凸不整なもの、白斑と紅斑が混在するものなどに分けることができる。癌化するものがあるので前癌病変の一つに数えられている。また、白斑と類似の肉眼所見を呈する扁平上皮癌があるので、癌腫との鑑別は重要である。表面が凹凸不整で粗造なタイプや白斑と紅斑が混在するタイプに癌の可能性が高いといわれている。



口腔白板症の癌化率

- ・ 海外では 0.13~17.5%
- ・ 我が国では 3.1~16.3%

口腔癌診療ガイドライン2019年版より引用

口腔白板症の癌化



口腔癌の肉眼分類

表在型: 表在性の発育を主とするもの
外向型: 外向性の発育を主とするもの
内向型: 内向性の発育を主とするもの

頸部リンパ節転移

舌癌(T1、T2)において、肉眼分類の表在型や外向型は頸部リンパ節転移率が低い。
一方、内向型では頸部リンパ節への転移率は前二者に比べて高くなる。

舌 癌

好発部位

- ・舌縁、舌下面
- ・舌縁中央部から後方部にかけてが最も多い
- ・舌背、舌尖にはまれ



臨床所見

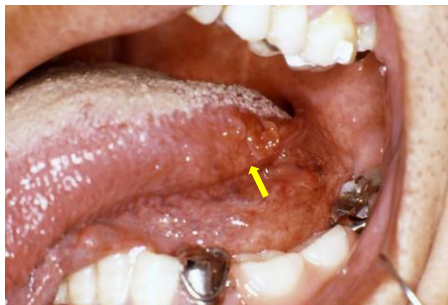
- ・初期にはびらん、小潰瘍、表面粗造な顆粒状局面
- ・進行すると、潰瘍と硬結を伴う



癌性潰瘍と義歯の刺激



舌の葉状乳頭を舌癌と間違え来院することがある。



舌癌の切除方法

①舌部分切除術

舌可動部の一部の切除、あるいは半側に満たない切除。

②舌可動部半側切除術

舌可動部のみの半側切除すなわち舌中隔までの切除。

③舌可動部(亜)全摘術

舌可動部の半側を超えた切除(亜全摘)、あるいは全部の切除。

④舌半側切除術

舌根部を含めた半側切除。

⑤舌(亜)全摘術

舌根部を含めた半側以上の切除(亜全摘)、あるいは全部の切除。

舌 癌

患 者: 69歳、女性。

初 診: 20XX年3月。

主 訴: 食べ物を食べると舌に違和感がある。

既往歴: 急性腎炎、喘息。

家族歴: 特記事項なし。

現病歴: 3か月前より舌下部に口内炎ができ、治りきらないため、
かかりつけ歯科受診。
左側舌下部に白色扁平隆起を確認したため来科。

現 症: 左側舌下面に15×8mm大の白板を認めた。
周囲硬結、出血は認めなかった。

初診時口腔内所見



初診1か月後



術中所見



術中所見



摘出物



歯肉癌

下顎歯肉癌の切除方法

- ① 歯肉切除術
歯肉粘膜・骨膜のみの切除で骨切除を行わない。
- ② 下顎辺縁切除術
下顎骨の辺縁を保存し、下顎骨体を離断しない部分切除。
- ③ 下顎区域切除術
下顎骨の一部を歯槽部から下縁まで連続的に切除し、下顎体が部分的に欠損する切除。
- ④ 下顎半側切除術
一側の関節突起を含めた下顎骨の半側切除。

- ⑤ 下顎亜全摘術
下顎骨の半側を超える切除で、通常、下顎枝から対側下顎枝の範囲以上の切除。これに関節突起が温存されたか否かを追記する。
- ⑥ 下顎全摘術
両側の関節突起を含めて下顎骨を摘出する切除。

下顎歯肉癌

患 者: 68歳、男性。

初 診: 20XX年3月。

主 訴: 右側下顎第一大臼歯部の歯肉の違和感。

既往歴: 急性骨髄性白血病。

家族歴: 特記事項なし。

現病歴: 1か月前に右側下顎第一大臼歯部歯肉に疼痛自覚。
2週間前に白色病変を認めたため、歯科医院受診。
精査依頼にて紹介来科。

現 症: 右側下顎第一大臼歯類側歯肉に10mm大の白色
病変を認めた。

初診時口腔内所見



初診時パノラマX線



術中所見



術中所見 (tie-over法)



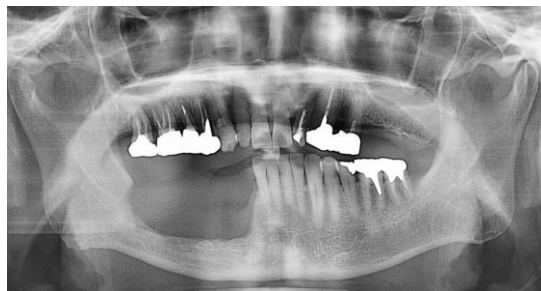
摘出物



tie-over除去後



術後パノラマX線



術後5か月



下顎歯肉癌

患 者: 75歳、男性。

初 診: 20XX年1月。

主 訴: 右側下顎部の疼痛。

既往歴: 特記事項なし。

家族歴: 特記事項なし。

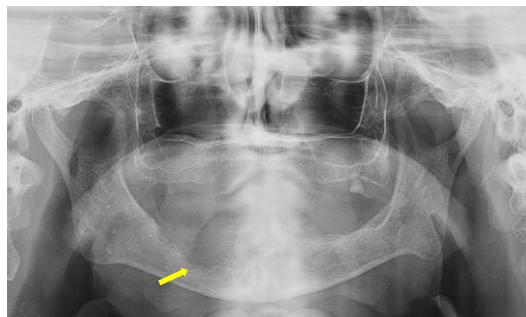
現病歴: 右側下顎顎堤部の潰瘍が徐々に増大したため
来科。

現 症: 右側下顎顎堤部に潰瘍を認めた。

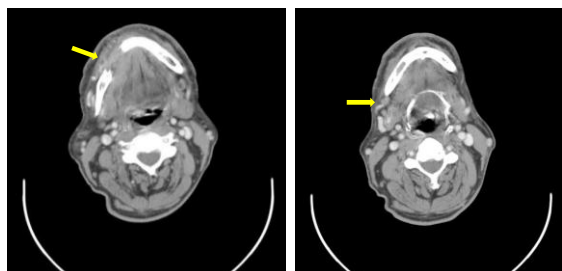
初診時口腔内所見



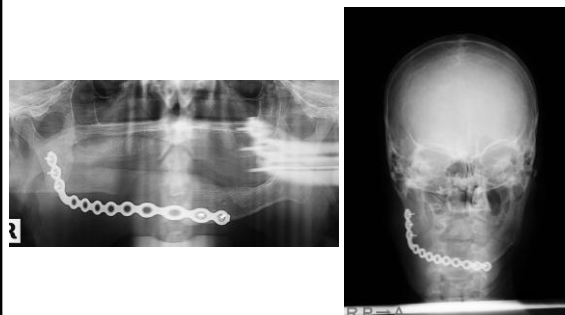
初診時パノラマX線



CT



術後X線



局所再発



術後



頬粘膜癌

頬粘膜癌

患 者: 77歳、男性。

初 診: 20XX年2月。

主 訴: 右側頬粘膜の腫瘍。

既往歴: 特記事項なし。

家族歴: 特記事項なし。

現病歴: 1年前より、右側頬粘膜に腫瘍を自覚。歯科治療にて受診した際、当科受診勧められ紹介来科。

現 症: 右側頬粘膜に境界明瞭な乳頭状腫瘍を認め、周囲に発赤が混在した白板を認めた。

初診時口腔内所見



術中所見



術中所見



摘出物



術後5か月



口底癌

患者: 92歳、女性。

初診: 20XX年2月。

主訴: 左側口底部の腫瘍。

既往歴: 高血圧症、脳梗塞。

家族歴: 特記事項なし。

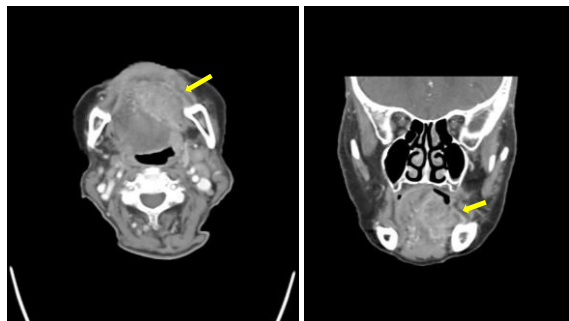
現病歴: 左側口底部の腫瘍の精査依頼にて紹介来科。

現症: 左側口底部正中から舌根部にわたる腫瘍を認めた。

初診時口腔内所見



CT



放射線治療中



放射線治療終了時



内視鏡を用いた消化管異物摘出

異物誤飲

患者: 50歳、男性。

初診: 20XX年8月。

主訴: 左側下顎臼歯部の補綴物誤飲。

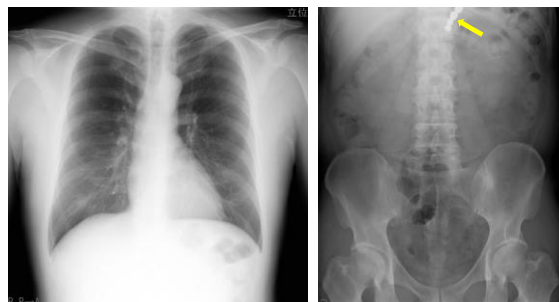
既往歴: 特記事項なし。

家族歴: 特記事項なし。

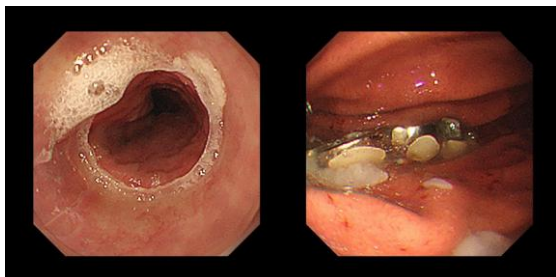
現病歴: 食事中に補綴物脱離。
食事と一緒に補綴物を誤飲したため、
紹介医を受診。精査依頼にて紹介来科。

現症: 左側下顎臼歯部の補綴物脱離。

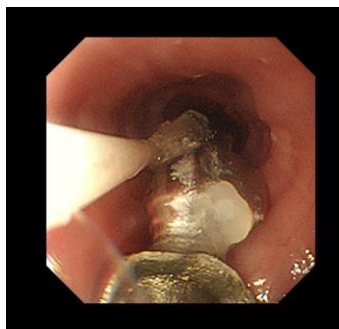
胸腹部単純X線



内視鏡所見



内視鏡所見



摘出物



異物誤飲

患 者: 78歳、女性。

初 診: 20XX年6月。

主 訴: 歯が取れて飲み込んでしまった。

既往歴: 基底細胞癌、高血圧症、骨粗鬆症。

家族歴: 特記事項なし。

現病歴: 2日前に右側下顎第二小臼歯の補綴物を誤飲し、排出の確認のため紹介来科。

現 症: 腹部X線にて、大腸に補綴物を認めた。

初診時腹部X線



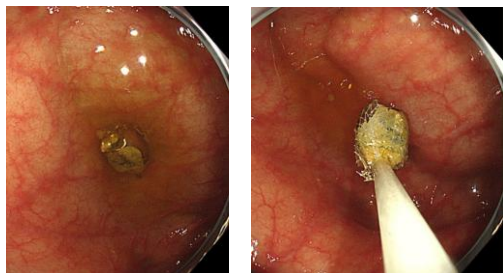
腹部X線



初診1週間後

初診2週間後

内視鏡所見



参考文献

- ・栗田賢一, 覚道健治: SIMPLE TEXT 口腔外科の疾患と治療, 第4版, 永末書店, 京都, 141-208頁, 2016.
- ・白砂兼光, 古郷幹彦: 口腔外科学, 第3版, 医歯薬出版, 東京, 183-296頁, 2016.
- ・日本口腔腫瘍学会, 日本口腔外科学会編:
口腔癌診療ガイドライン2019年版, 金原出版, 東京, 2019.